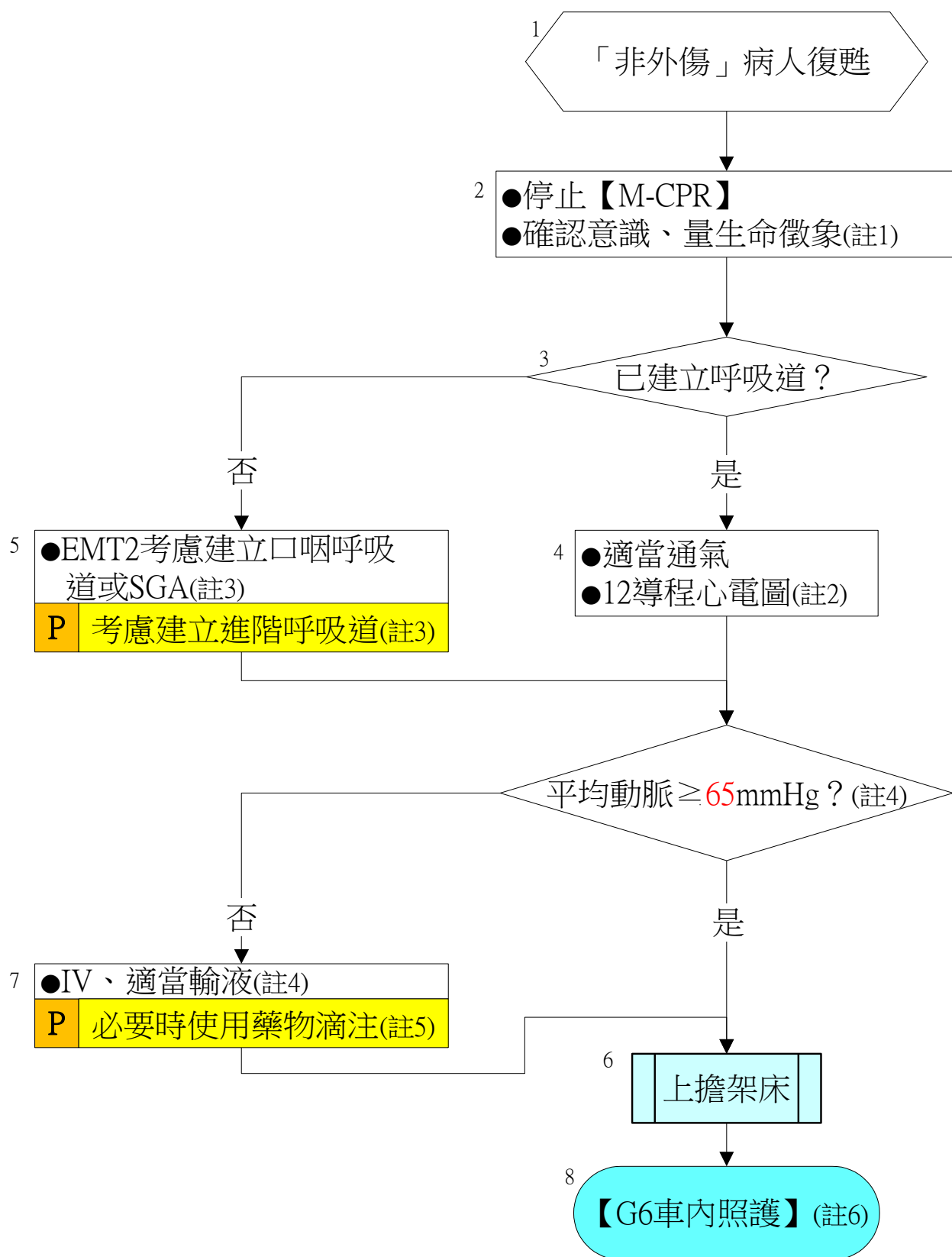


A4 復甦後照護

程 序



要 旨

- 一、凡18歲以上病人歷經內科原因所導致的到院前心跳停止，並於到院前恢復自主循環，即建議使用本程序。
- 二、於急救過程中EtCO₂數值突然上升可輔助EMT判斷病人是否恢復自主血液循環 (Return of spontaneous circulation, ROSC)，反之數值突然下降也可即時的幫助EMT發覺病人是否再次心跳停止，若儀器允許建議應常規使用於心跳停止或復甦後病人監測。
- 三、流程中應隨時注意病人病況是否有變化，必要時隨時參考【M1成人無脈搏】流程。
- 四、復甦後照護重點在於維持生命徵象並找尋可能導致心跳停止的原因，有鑑於此類病人病情極不穩定，若EMT於急救過程已使用AED或生理監視器，即使暫時恢復自主呼吸心跳或生命徵象穩定，仍不建議移除上述器材；若尚未使用心律監測儀器即復甦，仍建議於停止M-CPR後儘速使用，進行監測。
- 五、EMT執行此流程時，仍應注意後續送醫治療時效或考慮於後送過程中執行本流程。

註 解

註 1>

- 一、生命徵象量測建議應包含血壓、血氧及其他生命徵象，若當下量測不出不需反覆量測。
- 二、復甦後若病人意識尚未恢復可積極將體溫控制於32至37.5°C之間，提升病人較好的神經學預後。到院前救護溫度控制應以避免發燒、注意散熱為主，可考慮其他降溫方式但切勿以冰涼的靜脈輸液大量輸注來降溫。

註 2>

- 一、不論到院前12導程心電圖是否顯示為STEMI，到院後都建議主動與醫院交接，以利與到院後心電圖進行參照。
- 二、若到院前12導程心電圖顯示為STEMI，則應建議儘速通報，並將病人送至區域合作心血管中心。

註 3>

- 一、**P** 若病人意識已恢復但呼吸異常，可參照【M2呼吸困難】程序進行相關處置；若病人意識尚未恢復可參考【A1成人氣管內管插管】程序，考慮建立進階呼吸道。
- 二、進階呼吸道在病人搬運過程中有一定移位及滑脫之風險，除了固定外建議若器材允許

應合併EtCO₂使用，同時持續監測數值，避免在轉運過程中病人因通氣不良導致心跳停止再次發生。

三、若病人牙關緊閉或有其他無法建立進階呼吸道等情況，在無相關禁忌症之前提下，應嘗試置入輔助呼吸道(例如鼻咽呼吸道或口咽呼吸道等)，盡可能維持良好通氣途徑。

註 4>

一、輸液途徑包含靜脈注射(Intravenous access)以及EMTP可考慮骨內注射(Intraosseous vascular access)。

二、到院前復甦後病人照護，不論是靜脈注射或是骨內注射，當建立失敗時，嘗試建立輸液途徑建議以2次(或5分鐘)為限，避免因反覆嘗試延誤送醫時效。

三、復甦後照護適當輸液收縮壓(Systolic blood pressure, SBP)建議維持大於90毫米水銀柱。

四、復甦後照護適當通氣目標包含：

(一) 通氣次數保持每分鐘 10 次為初始值(約 6 秒一口氣)。

(二) 血氧飽和度(SpO₂)建議維持在 90-98%之間。低血氧(hypoxemia)對於復甦後病人預後有不良影響建議避免；至於高血氧(hyperoxemia)有加重全身發炎反應及腦部損傷之可能，所以也不建議將血氧飽和度維持於過高的水平。

(三) 平均動脈壓(MAP)>65mmHg(MAP 大約=1/3SBP+2/3DBP，SBP ≥ 90 mmHg、DBP ≥ 60 mmHg)，範例如下：

MAP (mmHg)	SBP (mmHg)	DBP (mmHg)
65	90	53
65	100	48
65	110	43
65	120	38

(四) 維持 ETCO₂ 35-40 mmHg。

註 5> **P**

一、適當輸液量後仍無法達到前述血壓目標，可嘗試以簡易型*腎上腺素靜脈滴注(Dirty Epinephrine Drip)來提升病人血壓。

二、簡易型腎上腺素靜脈滴注應經線上醫療指導同意，使用劑量為將1支 Epinephrine加入 N/S 500ml (=2mcg/ml)，調整點滴數從每秒1滴開始 (此時劑量為6 mcg/min; 即為0.1 mcg/kg/min在體重60公斤之病人)。



$$\text{劑量(mcg/kg/ min)} = \frac{\text{每秒滴數} \times 60 \div 20(\text{標準點滴套}) \times \text{濃度(mcg /min)}}{\text{體重(kg)}}$$



三、到院前應完成輸液瓶罐外標示，到院後也應主動與交接使用劑量及滴注時間。

註 6>

一、通報後送醫、持續監測生命徵象。

二、**P**必要時參考【M8嚴重緩脈】、【M9嚴重頻脈】程序、聯絡線上醫療指導，給予相關處置。

